MINISTERIO DE SALUD

No. 664-2025/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 07 de OCTUBRE del 2025

Visto, el Expediente N° DIGTEL-DITEL20250000569, que contiene el Informe N° D00009-2025-DIGTEL-DITEL-THD-MINSA de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias; el Informe N° D000203-2025-OGTI-OIDT-EGRSD-MINSA de la Oficina General de Tecnologías de la Información; así como, el Informe N° D000949-2025-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Asimismo, dispone que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea, siendo responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, asimismo, el artículo 123 de la Ley Nº 26842, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, precisa que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como Organismo del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;

Que, los numerales 1) y 8) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en Salud de las Personas, así como, en Infraestructura y Equipamiento en Salud;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias, establece que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los sub numerales 4-A1 y 4-A2 del artículo 4 del antes citado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, refiere que, la potestad rectora del Ministerio de Salud comprende la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar y, cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que comprenden la materia de salud. La rectoría en materia de salud dentro del sector la ejerce el Ministerio de Salud por cuenta propia o, por delegación expresa, a través de sus organismos públicos adscritos y, dentro del marco y los límites establecidos en la dicha Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial y, las normas que rigen el proceso de descentralización. Asimismo, el Ministerio de Salud, como ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de sus competencias, determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás instituciones públicas, privadas y público-privadas.

Que, los literales a) y h) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, establecen que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, conducir, regular y supervisar el Sistema Nacional de Salud, así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud;

Que, artículo 1 de la Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud, establece los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telesalud como una estrategia de prestación de servicios de salud, a fin de mejorar su eficiencia y calidad e incrementar su cobertura mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el sistema nacional de salud;

Que, el literal a) del artículo 3 de la Ley Marco de Telesalud, establece que la telesalud es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación-TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población. Este servicio se efectúa considerando los siguientes ejes de desarrollo de la telesalud: la prestación de los servicios de salud, la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud;

Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley Nº 30421, Ley Marco de Telesalud, y del Decreto Legislativo Nº 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la telesalud, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2021-SA, dispone que, el Ministerio de Salud diseña, formula, planea, dirige, conduce, coordina, regula, supervisa y evalúa periódicamente la Política Nacional y Sectorial de Telesalud. Asimismo, señala que, la Política Nacional y Sectorial de Telesalud, fortalece el desarrollo y la implementación de los servicios de salud, contribuyendo a garantizar la calidad, oportunidad y eficiencia de los mismos; para ello, la Política Nacional y Sectorial de Telesalud, se implementa por intermedio del Plan Nacional y los Planes Regionales y de Lima Metropolitana, que permiten articular la intervención pública y privada, para sostener el desarrollo e implementación de los servicios de telesalud, en bienestar de la población;

Que, el artículo 103 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, establece que la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, responsable de formular e implementar la política de telesalud en el Sector Salud. Es responsable de implementar infraestructura tecnológica interoperable que permita la articulación de los servicios de telesalud, los servicios de Consejería integral en Salud-INFOSALUD y los Servicios de Atención Móvil de Urgencias. Gestiona la articulación de la información en salud y los servicios de salud a través del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC);

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 07 de OCTUBRE del 2025

Que, asimismo, los literales a), b), c), d) y e) del artículo 104 del antes citado Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establecen que son funciones de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, proponer, coordinar, supervisar, evaluar y dirigir la política sectorial de telesalud, bajo cuyo marco elabora el Plan Nacional de Telesalud, para proponer normas, lineamientos, planes, estrategias para implementar los ejes de desarrollo de la telesalud y para gestionar la Telegestión de la telesalud en el Sector Salud; asimismo, articular y evaluar la Red Nacional de Telesalud, en sus ejes de desarrollo: La prestación de los servicios de salud, la gestión de los servicios de salud, la información, la educación y comunicación a la población sobre los servicios de salud, y el fortalecimiento de capacidades del personal de salud; implementar la infraestructura tecnológica interoperable para articular los servicios de telesalud, INFOSALUD y el SAMU; y, normar y gestionar la articulación de la información en salud y los servicios de salud a través del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC);

Que, mediante Resolución Ministerial 356-2022/MINSA, se dispone que los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas cuya titularidad sea ejercida por el Ministerio de Salud, se denomine Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE del MINSA, con alcance a los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención, quedando modificado en dicho sentido los documentos normativos que se hayan establecido para estos fines;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 553-2025/MINSA, se disponer que el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE del MINSA, sea implementado y usado de manera obligatoria en los establecimientos de salud del primer nivel de atención del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 608-2025/MINSA se aprueba la NTS N° 232-MINSA/DIGTEL/2025: "NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD"; con la finalidad de contribuir a mejorar el acceso equitativo y la calidad de los servicios de salud a los usuarios mediante el uso de la telesalud, promoviendo la complementariedad, continuidad y sostenibilidad del cuidado integral de la salud, centrado en la persona, su entorno familiar y su comunidad, procurando un Sistema Nacional de Salud eficiente;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, en el marco de sus competencias y funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, a través del documento del visto, considera la necesidad de actualizar la NTS N° 232-MINSA/DIGTEL/2025: "NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD", a fin de

fortalecer el SIHCE del MINSA, en su componente de telemedicina, para su uso en la gestión de la información relacionada a las prestaciones de telemedicina;

Con el visado de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias; de la Oficina General de Tecnologías de la Información; de la Oficina General de Asesoría Jurídica; de la Secretaría General; y, del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 235- MINSA/DIGTEL/2025, "NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD" que, como anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 608-2025/MINSA, que aprueba la NTS N° 232-MINSA/DIGTEL/2025: "NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD".

Articulo 3.- Encargar a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias que efectúe la difusión, implementación, supervisión y asistencia técnica de la Norma Técnica de Salud que se aprueba mediante la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la misma y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

NORMA TÉCNICA DE SALUD N°235 MINSA/DIGTEL/2025 NORMA TÉCNICA DE SALUD EN TELESALUD

I. FINALIDAD

Contribuir a mejorar el acceso equitativo y la calidad de los servicios de salud a los usuarios mediante el uso de la Telesalud, promoviendo la complementariedad, continuidad y sostenibilidad del cuidado integral, centrado en la persona, su entorno familiar y su comunidad, procurando un Sistema Nacional de Salud eficiente.

II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer un marco normativo que regule y articule la implementación y el desarrollo de los ejes de la Telesalud, garantizando el acceso oportuno, equitativo y de calidad a la atención en salud, mediante el uso eficiente, ético y seguro de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante TIC), incluyendo las tecnologías emergentes, en concordancia con los principios de integralidad, universalidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Determinar las disposiciones técnicas y operativas para la implementación de los ejes de la Telesalud, para facilitar la continuidad de la atención asistencial.
b. Fomentar y desarrollar los ejes de Telesalud en los servicios de salud a través de Telesalud.
c. Establecer disposiciones sobre los criterios para la aplicación e integración de las TIC en los servicios de salud a través de Telesalud.
d. Contribuir en el fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la provisión de servicios de Telesalud.
e. Definir los mecanismos de control a través de la supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación del impacto de los servicios de Telesalud a nivel nacional.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica de Salud son de aplicación obligatoria en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (en adelante IPRESS) públicas a cargo del Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales y Locales, el Seguro Social de Salud- EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, en las IPRESS privadas y mixtas; así como en entidades que desarrollan los ejes de la Telesalud.

IV. BASE LEGAL

4.1. Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
4.2. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias.
4.3. Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y sus reglamentos.
4.4. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento.
4.5. Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.
4.6. Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud y su modificatoria.

4.7. Ley Nº 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).
4.8. Ley N° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.
4.9. Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
4.10. Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y su Reglamento.
4.11. Decreto Legislativo N° 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
4.12. Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
4.13. Decreto Supremo Nº 003-2024-JUS, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
4.14. Decreto Supremo N° 005-2025-SA, que aprueba la Agenda Digital del Sector Salud hacia el 2030.
4.15. Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
4.16. Resolución Ministerial N° 502-2016-MINSA, que aprueba la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02, "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud".
4.17. Resolución Ministerial Nº 120-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 230-MINSA/2017/OGTI, "Directiva Administrativa que establece los estándares y criterios técnicos para el desarrollo de los sistemas de información en salud".
4.18. Resolución Ministerial N° 464-2019/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 266-MINSA/2019/OGTI: "Directiva Administrativa que regula la Interoperabilidad en los Sistemas de Información Asistencial".
4.19. Resolución Ministerial Nº 116-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 284-MINSA/2020/DIGTEL: "Directiva de Telegestión para la implementación y desarrollo de Telesalud".
4.20. Resolución Ministerial Nº 117-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 285-MINSA/2020/DIGTEL: "Directiva para la implementación y desarrollo de los servicios de Telemedicina síncrona y asíncrona".
4.21. Resolución Ministerial N° 146-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 286-MINSA/2020/DIGTEL: "Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo de los Servicios de Teleorientación y Telemonitoreo".
4.22. Resolución Ministerial Nº 653-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Bases Conceptuales para el ejercicio de la rectoría sectorial del Ministerio de Salud.
4.23. Resolución Ministerial N° 688-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 294-MINSA/2020/OGTI, Directiva Administrativa que establece el tratamiento de los datos personales relacionados con la salud o datos personales en salud.
4.24. Resolución Ministerial N° 826-2021-MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".
4.25. Resolución Ministerial N° 090-2022-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 326-MINSA/OGPPM-2022, Directiva administrativa para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes específicos en el Ministerio de Salud.

4.26. Resolución Ministerial N° 462-2023/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que regula el uso de la firma electrónica y de la firma digital en los actos médicos y actos de salud.
4.27. Resolución Ministerial N° 432-2025-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 378-MINSA/DGAIN-2025, "Directiva Administrativa para la programación de turnos de trabajo del profesional de la salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales".
4.28. Resolución Ministerial N° 164-2025/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 373-MINSA/OGTI-2025 Directiva Administrativa que establece el proceso de acreditación de los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas.
4.29. Resolución Ministerial N° 553-2025-MINSA, que dispone que el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE del MINSA, sea implementado y usado de manera obligatoria en los establecimientos de salud del primer nivel de atención del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

a. Accesibilidad
Es el grado en que el producto, dispositivo, servicio o entorno (virtual o real) está disponible para la mayor cantidad de personas posible, principalmente para la población más vulnerable.

b. Acto médico
Es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica, pronóstico y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de estos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico.

c. Acto de salud
Es toda acción o actividad que realizan los profesionales de la salud, excepto el Médico Cirujano, para las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, según corresponda; que se brindan al paciente, familia y comunidad. La recuperación incluye la evaluación clínica, diagnóstico, pronóstico, terapéutica y seguimiento, según las competencias de cada profesional de la salud, de acuerdo a Ley.

d. Alfabetización digital
Es el proceso de adquisición de competencias esenciales para interactuar en entornos digitales permanentemente; necesario para estudiar, trabajar, desenvolverse en la vida diaria, que permite ejercer la ciudadanía de manera plena y aprovechar las oportunidades que brinda el entorno.

e. Asistencia Técnica
Es el proceso planificado, permanente e interactivo mediante el cual se fortalecen los conocimientos, habilidades y destrezas de una unidad de organización que

requiere de ella, por parte de otra unidad de organización con experiencia técnica y competencias funcionales para hacerlo.

f. Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud
Es el procedimiento sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento, por los profesionales de salud, de los usuarios de manera individual, y que tiene como finalidad fundamental la búsqueda de la mejora continua de las atenciones en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.

g. Auditoría Informática
Es la actividad programada o inopinada que consiste en recolectar, consolidar y evaluar evidencia para comprobar si la entidad ha implementado controles, protección de los activos, mantenimiento de la integridad de los datos, seguridad informática y uso eficaz y eficiente de los recursos.

h. Calidad de la atención (QoC)
Es el grado en que los servicios de salud para la atención individual y colectiva aumentan la probabilidad de obtener los resultados de salud deseados.

i. Cartera de servicios de salud
Es el conjunto de diferentes prestaciones de salud individual y de salud pública que brindan las RIS, a través de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, con base en sus recursos humanos y recursos tecnológicos que responden a las necesidades de salud de la población y a las prioridades de políticas sanitarias sectoriales.

j. Datos personales
Es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Asimismo, es toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo, de una persona natural que la identifica o la hace identificable individualmente, a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

k. Datos personales relacionados con la salud
Es aquella información concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada, física o mental, de una persona, incluyendo el grado de discapacidad y su información genética.

l. Dispositivo médico
Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno o más de los siguientes propósitos específicos:
- Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad.
- Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión.
- Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico.
- Soporte o mantenimiento de la vida.

- Control de la concepción.
- Desinfección de dispositivos médicos.

m. Entidades que desarrollan los ejes de la Telesalud
Son aquellas encargadas de desarrollar e implementar los ejes de Telesalud que no son prestacionales (telegestión, telecapacitación, telelEC), a fin de establecer estrategias que mejoren los servicios de salud a través de Telesalud.

n. Estación móvil de Telemedicina
Es una estructura resistente y móvil, que está integrada por equipamiento biomédico y tecnológico, diseñado para facilitar la prestación de servicios de Telesalud directamente en el punto de atención del usuario o en áreas con limitada infraestructura, permitiendo la toma de signos vitales, adquisición de imágenes diagnósticas, transmisión de datos y la comunicación de manera síncrona y asíncrona.

o. Evaluación
Es uno de los procesos de la función de control gerencial destinado a la valoración sistemática, basada en evidencias, del logro de los objetivos de una política, programa o proyecto en curso o concluido, desde su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. Su propósito es determinar la pertinencia de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo a través del adecuado proceso de toma de decisiones.

p. Historia Clínica Electrónica
Es la Historia Clínica registrada en forma unificada, personal y multimedia, refrendada con la firma digital del médico u otros profesionales de salud, cuyo tratamiento (registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso), se realiza en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y disponibilidad a través de un Sistema Información de Historias Clínicas Electrónicas, de conformidad con las normas aprobadas por el MINSA, como órgano rector competente.

q. Infraestructura Tecnológica
Elementos de las Tecnologías de la Información que soportan la operación de la institución, entre los que se encuentran la plataforma hardware, la plataforma de comunicaciones y el software especializado (sistema operacional, software de comunicaciones, software de integración y manejadores de base de datos, entre otros).

r. Interoperabilidad
Es la capacidad de las organizaciones para intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y eficiente los datos, la información y los documentos, por medios electrónicos entre sus sistemas de información. Es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo compartan información y conocimientos mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones.

s. Inteligencia Artificial (IA)
Tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global sostenible positiva, aumentar la innovación y la productividad, y ayudar a responder a los desafíos globales clave.

t. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR)
Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos (en adelante AE) que integran una Unidad Productora (en adelante UP) en funcionamiento y que tienen por objeto adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP y evitar la interrupción del servicio de una UP o minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro en sus estándares de calidad.

u. IPRESS consultante
La IPRESS ubicada principalmente en un área geográfica con limitaciones de acceso o capacidad resolutiva, y que cuenta con TIC, a fin de acceder a servicios de Telemedicina de una o más IPRESS consultoras.

v. IPRESS consultora
La IPRESS registrada con el servicio de Telesalud en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (en adelante RENIPRESS) que cuenta con TIC y brinda servicios de Telemedicina a la IPRESS consultante.

w. Monitor grado médico
Pantalla de alta resolución que sirve para visualizar con la mejor calidad y detalle posible las imágenes médicas provenientes de diversas modalidades de exámenes como ultrasonido, rayos X, mamografía, tomografía computarizada (, resonancia magnética (endoscopia y microscopía digital, entre otras, cumpliendo con una serie de estándares y regulaciones internacionales para garantizar la precisión, fiabilidad y seguridad necesarias en el diagnóstico.

x. Personal de la Salud
Está compuesto por profesionales de la salud, personal técnico y auxiliar asistencial de la salud, que participan en el proceso de atención del paciente o usuario de salud.

y. Personal de soporte TIC
Profesionales en ingeniería de áreas relacionadas a las TIC, y/o técnico de Tecnología de la Información, que gestionan sistemas, infraestructura, equipamiento y redes de información y comunicación, a fin de asegurar la implementación y sostenibilidad de los distintos ejes de Telesalud.

z. Receta electrónica
Es la receta médica en formato digital que cumple con lo establecido en las normas legales vigentes y que resulta de la prescripción que realiza un profesional de salud autorizado directamente en un programa informático y a través de dispositivos electrónicos de transmisión de datos (computadora personal, tablet y otros). Incluye la firma digital como respaldo del acto prescriptivo.

aa. Red Integrada de Salud (RIS)
Conjunto de organizaciones que presta, o hace los arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población definida, a través de la articulación, coordinación y complementación, y que rinde cuentas por los resultados sanitarios y administrativos y por el estado de salud de la población a la que sirve.

bb. Red Nacional de Telesalud (RNT)
Es el conjunto de IPRESS, procesos, personal y TIC que prestan el servicio de Telesalud a la población. La conducción, regulación, articulación y evaluación de la RNT está a cargo del Ministerio de Salud.

cc. Salud Digital
Es el conjunto de acciones y actividades que tienen por finalidad mejorar la salud de la población y los servicios asistenciales y administrativos mediante las tecnologías (a través de teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, entre otros)

dd. Seguridad de la Información
Es el conjunto de acciones para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, además de otras características como la autentificación, responsabilidad, no repudio y fiabilidad.

ee. Sistema de Gestión de la Calidad en Telesalud
Son una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias), para lograr la calidad de servicios que se ofrecen al usuario, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en la satisfacción del usuario y en el logro de los resultados deseados por la institución.

ff. Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas-SIHCE del MINSA
Conjunto de elementos humanos, organizacionales, normativos y de tecnologías de información y comunicaciones, que interactúan para el tratamiento de las historias clínicas electrónicas en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo o en un conjunto de ellos.

gg. Tecnologías Digitales
Se refieren a las TIC, incluidos Internet, las tecnologías y dispositivos móviles, así como la analítica de datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital.

hh. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
Son un conjunto de servicios, redes, softwares y dispositivos de hardware que se integran en sistemas de información interconectados y complementarios, con la finalidad de gestionar datos e información de manera efectiva, mejorando la productividad de los ciudadanos, gobierno y empresas, dando como resultado una mejora en la calidad de vida.

ii. Teleapoyo al diagnóstico
Es el servicio de salud de apoyo al diagnóstico a distancia mediante el uso de las TIC, en el proceso de atención de salud bajo la modalidad Telesalud al paciente; incluye diagnóstico por imágenes, patología clínica, anatomía patológica, entre otros.

jj. Telecapacitación
Es el proceso de enseñanza/aprendizaje mediante el uso de las TIC, realizado por personal especializado con las competencias necesarias, orientado a ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes del personal de la salud.

kk. Teleconsulta
Es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de la salud, en el marco de sus competencias, y una persona usuaria mediante el uso de las TIC, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

ll. Teleconsulta en Línea
Es la consulta a distancia en tiempo real (síncrona), que se realiza entre un profesional de la salud, en el marco de sus competencias, y una persona usuaria mediante el uso de las TIC, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso; cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

mm. Teleconsulta fuera de Línea
Es la consulta a distancia en tiempo diferido (asíncrona), que se realiza entre un profesional de la salud, en el marco de sus competencias, y una persona usuaria mediante el uso de las TIC, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso; cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

nn. Teleconsultante
Personal de la salud que labora en una IPRESS consultante, quien solicita servicios de Telemedicina a una o más de una IPRESS consultora.

oo. Teleconsultor
Médico especialista, médico cirujano, u otro profesional de la salud, que labora en una IPRESS consultora y brinda servicios de Telemedicina a uno o más teleconsultantes.

pp. Teleecografía en línea
Es el examen de imágenes médicas a distancia mediante el uso de TIC, realizada en una IPRESS consultante, adquirida por médico cirujano a médico especialista primordialmente médico especialista en radiología mediante la transmisión de

imágenes, en tiempo real (síncrona), para interpretación asistida o segunda opinión de un examen de ultrasonografía bidimensional (2D), tridimensional (3D), 4D, 5D Doppler, Ecografía elastográfica y otras; en ambiente específico. Incluye transmisión y/o transferencia de las imágenes realizadas y los resultados registrados.

qq. Teleecografía fuera de línea
Es el examen de imágenes médicas a distancia mediante el uso de TIC, realizada en una IPRESS consultante, adquirida por médico cirujano a médico especialista primordialmente médico especialista en radiología mediante la transmisión de imágenes, en tiempo diferido (asíncrona), para segunda opinión de un examen de ultrasonografía bidimensional (2D), tridimensional (3D), 4D,5D, Doppler, Ecografía elastográfica y otras; en ambiente específico. Incluye transferencia de las imágenes realizadas y los resultados registrados.

rr. Teleecografía + Teleconsulta en línea
Es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud para la atención de una persona usuaria; donde el diagnóstico se basa en la transmisión y/o transferencia de imágenes por Teleecografía en línea, desde la IPRESS consultante hacia la IPRESS consultora, cumpliendo con las restricciones reguladas y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

ss. Teleemergencia
Consulta a distancia mediante el uso de TIC, realizada por médico cirujano o especialista a otro médico especialista o sub especialista en ambiente específico recibiendo segunda opinión sobre el manejo de pacientes en condición de urgencia o emergencia.

tt. Teleinterconsulta
Es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no presente; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

uu. Teleinterconsulta síncrona
Es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, en tiempo real (en línea), para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no presente; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

vv. Teleinterconsulta asíncrona
Es la consulta a distancia mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación - TIC, que realiza un personal de salud a un profesional de la

salud, en tiempo diferido (fuera de línea), para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no presente; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.

ww. Teleinformación, educación y comunicación (TelelEC)
Es la comunicación a distancia, mediante el uso de las TIC, que permite ampliar o precisar los conocimientos que se tienen sobre salud, y está dirigido a la población en general o a un sector de esta, para difundir estilos de vida saludable, el cuidado de su salud, familia y comunidad.

xx. Telejunta médica
Es una teleconsulta sincrónica, realizada por un conjunto de médicos de distintas especialidades para la toma conjunta de decisiones diagnósticas, terapéuticas y pronóstico de un paciente, solicitadas por un teleconsultante en la que comparten información clínica y consentimientos del paciente.

yy. Telegestión
Aplicación de los principios, conocimientos y/o métodos de la gestión de salud, mediante el uso de las TIC, en la planificación, organización, dirección y control de los servicios de salud.

zz. Telemamografía fuera de línea
Es el examen de imágenes médicas realizado mediante el uso de las TIC, que se brinda en el servicio de tele apoyo al diagnóstico, solicitada o realizada por médico cirujano, tecnólogo médico en radiología y enviada a médico especialista en radiología, en tiempo diferido (asíncrona),mediante la adquisición, transmisión y visualización a distancia de imágenes de mamografías para su interpretación por parte de un radiólogo especializado en mama; en un ambiente específico que incluye transferencia de las imágenes realizadas y los resultados obtenidos.

aaa. Telemedicina
Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población.

bbb. Telemedicina internacional
Es la provisión de servicios de salud a distancia que utiliza las TIC para la transferencia de información médica, diagnóstica y terapéutica, asegurando los estándares de seguridad de la información, la protección y tratamiento de datos personales en salud, en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de flujo transfronterizo; asegurando que los médicos nacionales se encuentren habilitados por el Colegio Médico del Perú; así como el establecimiento de salud de mayor nivel de complejidad a nivel nacional (Institutos) al cual pertenecen se encuentre registrado en la Superintendencia Nacional de Salud. En caso de médicos extranjeros (especialistas o sub especialistas), deben poseer la licencia para ejercer la medicina y estar habilitados legalmente en su país de origen; así como

encontrarse registrados en el establecimiento de salud donde brinden los servicios de salud a través de Telesalud. En caso de establecimientos de salud que brinden los servicios de salud a través de Telesalud en zonas de frontera con el Perú, estos deben brindarse en el marco de los tratados internacionales.

ccc. Telementoría
Es un proceso de acompañamiento y apoyo en la tarea a desempeñar, así como la integración en el grupo o institución de referencia. La persona mentora/tutora cuenta con amplia formación profesional y experiencia y asume la responsabilidad de orientar y asesorar a la persona mentorizada en su desempeño profesional. Este proceso se encuentra en el ámbito de la Teleinterconsulta.

ddd. Telemonitoreo
Es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria, en las IPRESS, en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria, y si el caso lo amerita según criterio médico los parámetros biomédicos y/o exámenes auxiliares, como medio de control de su situación de salud. Se puede o no incluir la prescripción de medicamentos de acuerdo al criterio médico y según las competencias de otros profesionales de la salud.

eee. Teleorientación
Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades.

fff. Teleorientación síncrona
Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud en tiempo real (en línea), mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades.

ggg. Teleorientación asíncrona
Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud en tiempo diferido (fuera de línea), mediante el uso de las TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades.

hhh. Teletriaje
Es el proceso a distancia haciendo uso de las TIC, permite identificar el riesgo clínico o prioridad para la atención de usuarios de salud en las diferentes UPS/UPSS, lo que permite manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de atención de salud.

iii. Telesalud
Es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población. Este servicio se efectúa considerando los siguientes ejes de desarrollo de la Telesalud: la prestación de los servicios de salud,

la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud, entre otros.

jjj. Tratamiento de datos personales
Es cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión, de los datos personales.

kkk. Usuario de Telesalud
Persona beneficiaria directa de la oferta de los servicios de Telesalud.

5.2. SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANS:	Autoridad Nacional de Salud
ARS:	Autoridad Regional de Salud
ASLM:	Autoridad de Salud de Lima Metropolitana
CI:	Consentimiento Informado
CPMS:	Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud
CTDP:	Consentimiento del Tratamiento de Datos personales
DIGEMID:	Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
DIGEP:	Dirección General de Personal de la Salud.
DGOS:	Dirección General de Operaciones en Salud
DIGTEL:	Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias
DGIESP	Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
DIRESA:	Dirección Regional de Salud
DIRIS:	Dirección de Redes Integradas de Salud
DITEL:	Dirección de Telemedicina
DINFOSALUD	Dirección de Infosalud
ENSAP:	Escuela Nacional de Salud Pública
ESSALUD:	Seguro Social de Salud.
FAT:	Formato Atención de Telemedicina
FUA:	Formato Único de Atención
GERESA:	Gerencia Regional de Salud.
HIS:	Sistema de información HIS MINSA
HL7:	Séptimo nivel de salud (Health Level seven)
IA:	Inteligencia Artificial
IAFAS:	Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
INFORHUS:	Registro Nacional del Personal de la Salud
IOARR:	Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición
IPRESS:	Institución Prestadora de Servicios de Salud
INPE:	Instituto Nacional Penitenciario
MINSA	Ministerio de Salud
OGTI:	Oficina General de Tecnología de la Información
ISO:	Organización Internacional de Normalización o Estandarización
PNUME:	Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales.
PDP:	Plan de Desarrollo de las Personas
QoC:	Calidad de la atención
RENIPRESS:	Registro Nacional de IPRESS
REUNIS:	Repositorio Único Nacional de Información en Salud
RIS:	Redes Integradas de salud
RNT:	Red Nacional de Telesalud

TeleIEC:	Tele información, Educación y Comunicación
TIC:	Tecnologías de la Información y de la Comunicación
SISMED:	Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
UFT:	Unidad Funcional de Telesalud
UGIPRESS:	Unidades de Gestión de IPRESS
UPS:	Unidad Productora de Servicios
UPSS:	Unidad Productora de Servicios de Salud

5.3. La ANS, a través de la DIGTEL, define los requisitos mínimos para la incorporación a la RNT de las IPRESS que brindan los servicios de salud a través de Telesalud, que se especifica en el numeral 6.3 de la presente norma técnica.

5.4. La ANS a través de la DIGTEL, define cada año los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios de salud a través de Telesalud, en el marco de los convenios de gestión.

5.5. La ANS gestiona con las instituciones formadoras de profesionales de la salud, incluir en la formación de los profesionales y en la segunda especialización, las competencias digitales necesarias para brindar los servicios de salud a través de Telesalud.

5.6. La ANS en coordinación con el Ministerio de Educación identifica las líneas o niveles de soporte de las TIC; y determina las competencias vinculadas a la Telesalud, gestionando la incorporación de estas para la formación de los estudiantes de las instituciones formadoras, como los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica.

5.7. Las Universidades suscriben convenios con las IPRESS que brindan los servicios de salud a través de Telesalud, para que médicos residentes de segunda especialización realicen sus rotaciones en las mencionadas IPRESS.

5.8. La ARS (DIRESA, GERESA) y la ASLM (DIRIS), articulan y organizan los servicios de salud a través de Telesalud en las IPRESS de su jurisdicción.

5.9. La ANS, la ARS y ASLM, identifican la demanda para implementar la cartera de servicios de salud a través de Telesalud con teleapoyo al diagnóstico tales como: Telerradiografía (Telerradiografía fuera de línea), Teleresonancia magnética, Teleecografía (Teleecografía fuera de línea, Teleecografía + Teleconsulta en línea), Telemamografía (Telemamografía fuera de línea), Teletomografía (Teletomografía fuera de línea), telemetría cardiovascular móvil portátil con registro electrocardiográfico y son incluidas en su cartera de servicios de salud.

5.10. La ANS, la ARS y ASLM, implementan en sus IPRESS, los servicios de salud a través de Telesalud como: Telerradiografía (Telerradiografía fuera de línea), Teleresonancia magnética, Teleecografía (Teleecografía fuera de línea, Teleecografía + Teleconsulta en línea), Telemamografía (Telemamografía fuera de línea), Teletomografía (Telemamografía fuera de línea), telemetría cardiovascular móvil portátil con registro electrocardiográfico y son incluidas en su cartera de servicios de salud.

5.11. Las IPRESS que brindan servicios de salud a través de Telesalud, garantizan que los profesionales de la salud que realizan atención, cuenten con su firma digital según corresponda, así como, con los equipos y sistemas necesarios que garantizan su uso seguro.

5.12. La ANS aprueba el Plan Nacional de Telesalud, mediante Resolución Ministerial.

5.13. La ARS y ASLM aprueban el Plan de Telesalud en el ámbito de su jurisdicción, mediante acto resolutivo, pudiendo ser éste, Directoral o Gerencial. Los Planes de Telesalud están alineados al Plan Nacional de Telesalud.

5.14. La ANS, la ARS y ASLM brindan asistencia técnica a las IPRESS de su jurisdicción para la elaboración e implementación del Plan de Telesalud en coordinación con el MINSA.

5.15. La ARS, ASLM y las IPRESS según corresponda, elaboran conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de los equipos biomédicos utilizados, los que cuentan con el respaldo del Registro Sanitario otorgado por la autoridad competente.

5.16. Las IPRESS que brinden los servicios de salud a través de Telesalud, cuentan con un responsable de Telesalud o el que haga sus veces, denominado Coordinador de Telesalud.

5.17. Las IPRESS del tercer nivel de atención que brindan el servicio de Telemedicina Internacional, verifican que el proveedor del servicio y los profesionales de la salud estén debidamente acreditados contando con las licencias válidas y habilitadas.

5.18. El Coordinador General de Telesalud de la DIRESA/GERESA o DIRIS, cuenta con capacitaciones comprobables en Telesalud; y, éste capacita a los Coordinadores de Telesalud de las IPRESS que brindan los servicios de salud a través de Telesalud.

5.19. La ANS realiza la publicación de datos de Telesalud a través del REUNIS, Plataforma Nacional de Datos Abiertos u otros medios de difusión formal, según corresponda, para la visualización de:

- Indicadores estratégicos y operativos.
- Información relacionada a proyectos de inversión y/o derivados para el fortalecimiento de la Telesalud lo cual puede incluir: estado de los procesos, especificaciones técnicas de selección para la adquisición de equipamiento tecnológico y biomédico, entre otros.
- Información del cumplimiento de metas de los convenios de gestión de Telesalud.
- Conformación y estado de la Red Nacional de Telesalud (número de IPRESS-producción)
- Otros datos relacionados a Telesalud de acuerdo a la necesidad.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. DE LOS EJES DE TELESALUD

6.1.1. DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD - EJE DE TELEGESTIÓN

a. La ANS, a través de la DIGTEL brinda asistencia técnica normativa, a las DIRESA/GERESA o DIRIS, así como, a las instituciones o entidades privadas o mixtas de corresponder, sobre los servicios de salud a través de Telesalud, implementados a través del eje de Telegestión, a fin de fortalecer los servicios sanitarios de salud a distancia.

6.1.2. DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD - EJE DE TELEMEDICINA

a. La ANS, a través de la OGTI y la DGOS determinan las características técnicas y criterios mínimos de infraestructura física, tecnológica y equipamiento, aplicable a los servicios de salud a través de Telesalud.

b. La ANS, a través de la DIGTEL en coordinación con la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral a cargo de la DGIESP proponen, estrategias para atender la demanda de personas que requieren atenciones a distancia en la IPRESS que brinda servicios de salud a través de Telesalud (teleorientación,

teleconsulta, telemonitoreo, teleinterconsulta y teleapoyo al diagnóstico), según sea el caso.

c. La ANS, a través de la DIGTEL difunde los códigos del Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud (en adelante CPMS) de Telesalud aprobados, según normativa vigente para su registro y reconocimiento de la atención por las IAFAS correspondientes.
d. La ARS y ASLM, conforman la UFT o un equipo de trabajo, que dependen de su Unidad Ejecutora, de la DIRESA, GERESA o de la DIRIS de Lima Metropolitana. La mencionada conformación, se sujeta a lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.
e. La UFT o el equipo de trabajo, está conformada por: el Director o Gerente Regional o a quien delegue (lidera la UFT), fortaleciendo el eje de Telegestión, el responsable de promoción de la salud o quien haga sus veces que se encarga del eje de Teleinformación, educación y comunicación, el responsable de docencia e investigación que se encarga del eje de Telecapacitación y, el Coordinador General de Telesalud que se encarga del eje de Telemedicina, así como, el personal de soporte TIC que se encarga de la Tecnología de la Información y otros profesionales según la necesidad. Los mismos que son reconocidos mediante Resolución Directoral o Gerencial; la cual es publicada en el portal web de la institución.
f. La ARS y ASLM a través de la UFT o el equipo de trabajo, brinda a las IPRESS de su jurisdicción, las líneas de acción para el desarrollo de los servicios de salud a través de Telesalud; tomando en consideración las prioridades sanitarias en el ámbito nacional, regional o local.
g. La máxima autoridad de la IPRESS que brinda servicios de salud a través de Telesalud, designa a los integrantes de la UFT o equipo de trabajo, mediante documento formal, y es publicado en el portal de la institución.
h. Los integrantes de la UFT o el equipo de trabajo, se encargan de las siguientes actividades:
   - Coordinar con la DITEL de la DIGTEL del MINSA, para brindarles asistencia y soporte técnico normativo.
   - Revisar los procesos de atención de los servicios de salud a través de Telesalud.
   - Elaborar el Plan de Telesalud en la región o DIRIS según corresponda, considerando los siguientes ejes de desarrollo de la Telesalud: la prestación de los servicios de salud, la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud.
   - Identificar los actores regionales para la implementación del Plan de Telesalud en la región o DIRIS.
   - Realizar el control de las actividades programadas en el Plan de Telesalud en la región o DIRIS.
   - Participar de las actividades que organiza la ANS, referentes a la prestación de los servicios de salud a través de Telesalud.
   - Evaluar que las IPRESS de su jurisdicción cumplan con las características técnicas de criterios mínimos establecidos para solicitar a la DITEL su incorporación a la RNT.
   - Evaluar el cumplimiento de las características técnicas de criterios mínimos de las IPRESS de su jurisdicción para solicitar a la DITEL la incorporación a la RNT.

- Solicitar la programación de turnos del recurso humano para brindar los servicios de salud a través de Telesalud, para ser compartida con todas las IPRESS públicas a nivel nacional.
- Proponer planes de mejora, de los procesos de atención.
- Brindar asistencia técnica al personal de la salud que brinda los servicios de salud a través de Telesalud.

i. Las IPRESS gestionan la implementación de la automatización de la prescripción y dispensación de medicamentos, otros productos farmacéuticos y dispositivos médicos generados en la atención por Telemedicina, cumpliendo lo establecido en las normas vigentes.

j. Las IPRESS consultantes que brindan servicios de salud a través de Telesalud, aseguran la disponibilidad de medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y tratamientos farmacológicos, para lo cual, la UPSS Farmacia o el área de atención con medicamentos, realiza gestiones previas de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios necesarios para contar con el stock suficiente para la atención de las recetas generadas en esta actividad.

k. Las IPRESS que realizan atención pre hospitalaria, incorporan servicios de salud a través de Telesalud, según demanda identificada.

l. Las IPRESS con capacidad resolutiva, planifican los requerimientos necesarios, para la atención de teleemergencia.

m. Las IPRESS de primer nivel de atención que brindan servicios de salud a través de Telesalud, cuenta con un Coordinador de Telesalud o el que haga sus veces y cumple con las siguientes actividades:
   - Coordinar con la RIS de la DIRESA, GERESA en regiones o DIRIS en Lima Metropolitana, para brindarles asistencia para la implementación de los servicios de salud a través de Telesalud.
   - Elaborar el Plan de Telesalud de su IPRESS, en coordinación con su RIS según corresponda y con los actores locales para su implementación.
   - Realizar la evaluación de indicadores con respecto a los avances del Plan de Telesalud.
   - Participa de las actividades de Telesalud que organiza la RIS, DIRESA, GERESA, DIRIS o MINSA, según corresponda.
   - Requiere la programación de turnos del profesional de la salud de las IPRESS consultoras, para solicitar la atención en los servicios de salud a través de Telesalud, para ser compartida a todas la IPRESS públicas a nivel nacional, conforme se establece en el numeral 5.17 de la Directiva Administrativa N° 378-MINSA/DGAIN-2025, aprobada con Resolución Ministerial N° 432-2025-MINSA, o la que haga sus veces.

n. Las IPRESS de segundo y tercer nivel de atención, conforman la UFT o equipo de trabajo e implementan una mesa de trabajo que dependen de la Jefatura o Dirección General de la IPRESS; la UFT está conformada por: el Jefe o Director General de la IPRESS o a quien delegue (lidera la UFT), fortaleciendo el eje de Telegestión, el responsable de promoción de la salud o quien haga sus veces que se encarga del eje de Teleinformación, educación y comunicación, el responsable de docencia e investigación que se encarga del eje de Telecapacitación y, el Coordinador General de Telesalud que se encarga del eje de Telemedicina, así como el personal de soporte TIC que se encarga de la Tecnología de la Información y otros profesionales según la necesidad.

o. Las IPRESS consultoras integran dentro de su cartera de servicios de salud, los servicios de Telesalud de acuerdo a la demanda atendida especificando si son

IPRESS consultantes, IPRESS consultoras o ambas, así como el tipo de servicio de Telemedicina que ofertan (teleorientación, teleconsulta, telemonitoreo, telejunta médica, teleinterconsulta, teleapoyo al diagnóstico), detallando si son atenciones síncronas o asíncronas, alineando sus intervenciones a las actividades de los programas presupuestales, las estrategias sanitarias, epidemiológicas, sociales y culturales del ámbito de intervención.

p. Las IPRESS consultantes que brindan los servicios de salud a través de Telesalud, confirman la cita de la teleconsulta a través del SIHCE del MINSA en su componente de Telemedicina.
q. El personal de la salud de la IPRESS que brinda los servicios de salud a través de Telesalud, registra los códigos del CPMS de Telemedicina en el SIHCE del MINSA u otro sistema asistencial según norma vigente.
r. En los usuarios afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el teleconsultante y el teleconsultor registran la prestación del servicio de salud a través de Telesalud en el FUA, siendo el teleconsultante el responsable de la atención a través del componente de Telemedicina del SIHCE del MINSA.
s. El profesional de la salud, registra el acto médico y/o acto de salud de la atención de salud a través de Telesalud en la Historia Clínica física, informatizada o Historia Clínica Electrónica, de acuerdo a la norma vigente.
t. Las IPRESS consultantes, según corresponda hacen uso del FAT/FUA, el Formato de Consentimiento Informado y el Formato de Tratamiento de Datos Personales de Telemedicina para solicitar la atención al teleconsultor.
u. El teleconsultor registra todos los aspectos de la prestación del servicio de salud en el lado reverso del FAT; posteriormente, el teleconsultante incluye la documentación correspondiente con su respectiva firma digital según corresponda, como parte de los registros en la Historia Clínica.
v. El Consentimiento de tratamiento de los datos personales de Telemedicina de los pacientes que acceden a los servicios de salud a través de Telesalud es otorgada a través de la firma digital (o cualquier otro mecanismo de autenticación que garantice la voluntad inequívoca de este o de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente). Se encuentran exceptuados de este punto las situaciones de emergencia, de riesgo, debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública.
w. Las IPRESS solicitan el Consentimiento Informado al usuario de Telesalud para la atención en los servicios de salud a través de Telesalud.
x. El usuario de Telesalud o su representante legal brinda su Consentimiento Informado para recibir los servicios de Telemedicina, el mismo que se encuentra vigente hasta su revocatoria. Se encuentran exceptuados de este punto las situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública.
y. En caso de que las IPRESS públicas no cuenten con un sistema de información asistencial interoperable con el SIHCE del MINSA, utiliza el FAT, de forma física para solicitar la teleinterconsulta síncrona o asíncrona a la IPRESS consultora, enviándolo a través de un correo institucional.
z. El FAT consta de dos secciones:
   - Solicitud de los servicios de Telemedicina, correspondiente al teleconsultante (anverso del formato).
   - Atención de los servicios de Telemedicina, correspondiente al teleconsultor (reverso del formato).

aa. En las IPRESS consultoras que realizan la telejunta médica, esta es convocada por el médico tratante, quien, junto al equipo multidisciplinario, evalúa, define el diagnóstico, pronóstico y plantea el esquema terapéutico (farmacológico y/o no farmacológico), para el usuario de Telesalud.
bb. En las prestaciones de teleapoyo al diagnóstico, el teleconsultante realiza y registra el procedimiento y el teleconsultor registra la interpretación diagnóstica, y remite el informe de la lectura.

6.1.3. DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SALUD - EJE DE TELECAPACITACIÓN

a. La ANS, a través de la Dirección de Infosalud de la DIGTEL realiza acciones informativas con fines educativos ejecutados a distancia (sincrónica) mediante el uso de las TIC, que se pone a disposición del recurso humano en salud de manera complementaria a los programas de capacitación que la ENSAP desarrolla en el marco del fortalecimiento de capacidades del personal de la salud.
b. La ANS, a través de la ENSAP, establece criterios de certificación, habilitación y acreditación para los profesionales que han recibido de la Escuela, cursos, diplomados y otros, en temas de Telesalud.
c. La ANS, en coordinación con la ENSAP, planifica y ejecuta actividades formativas en el marco de sus competencias académicas, en coordinación con la DITEL-DIGTEL a partir de los perfiles de competencias establecidos, a fin de fortalecer las capacidades en temas de Telesalud a nivel nacional, así como con otras instituciones autorizadas mediante convenios nacionales e internacionales.
d. Contribuir a través de instituciones académicas autorizadas como la ENSAP, en el fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la provisión de servicios de Telesalud y la adaptación a las nuevas tecnologías, garantizando estándares de calidad y seguridad en la atención.
e. La ANS, a través de la DIGEP en coordinación con la DIGTEL define el perfil de competencias de los coordinadores generales en Telesalud en DIRESA, GERESA y DIRIS y de los coordinadores en IPRESS nacionales y regionales.
f. La ANS, a través de la DIGEP establece las competencias y la estrategia de desarrollo y fortalecimiento de capacidades del personal de salud para la provisión de servicios de Telesalud y la adaptación a las nuevas tecnologías, garantizando la calidad y la seguridad de la atención.
g. La ANS, brinda asistencia técnica a las DIRESA, GERESA o DIRIS para incorporar actividades de Telecapacitación en su respectivo Plan de Telesalud.
h. La DIRESA, GERESA o DIRIS desarrollan la Telecapacitación al personal de la salud de las IPRESS de su jurisdicción, que son incluidas dentro del PDP y que abordan temas relacionados a las necesidades de salud identificadas y priorizadas a través del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), así como la incorporación de actividades para el fortalecimiento de capacidades en el Plan de Telesalud, aprobado para el periodo correspondiente.
i. La DIRESA, GERESA o DIRIS garantizan el almacenamiento tecnológico para documentar y registrar las Telecapacitaciones síncronas o asíncronas.
j. La DIRESA, GERESA o DIRIS, desarrollan Telecapacitaciones tomando en cuenta las competencias digitales del personal de la salud y personal de soporte tecnológico de las IPRESS de su jurisdicción.
k. La DIRESA, GERESA o DIRIS y/o IPRESS, coordinan ante la DINFOSALUD el uso de la plataforma para realizar Telecapacitaciones.

l. La DIRESA, GERESA o DIRIS establecen convenios con instituciones educativas de nivel superior o con rango universitario para la certificación de la Telecapacitaciones.

6.1.4. DE LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD - EJE DE TELEIEC

a. La ANS, a través de la DIGTEL, identifica y prioriza temas en el ámbito preventivo promocional para desarrollar actividades de TeleIEC en la población.
b. La ANS, cuenta con un repositorio digital audiovisual que alberga la información desarrollada de TeleIEC.
c. La DIRESA, GERESA o DIRIS implementan las TeleIEC, las cuales son programadas, planificadas y ejecutadas anualmente por la IPRESS de su jurisdicción, en coordinación con los responsables de los Programas Sanitarios.
d. La DIRESA, GERESA o DIRIS e IPRESS, coordina ante la DINFOSALUD el uso de la plataforma para realizar las TeleIEC.
e. La RIS emite una constancia de participación a los ponentes que desarrollan los temas de TeleIEC.
f. Las IPRESS desarrollan actividades de TeleIEC, identifican el nivel de alfabetización digital de la población objetivo, priorizando población vulnerable, por curso de vida, grupos de riesgo, pueblos indígenas u originarios y de frontera, con enfoque intercultural desde el diseño, el desarrollo de los contenidos y la metodología de aprendizaje.
g. El responsable de Telesalud o el que haga sus veces en la IPRESS, programa las actividades de TeleIEC.
h. Las TeleIEC que desarrollan las IPRESS contienen un lenguaje comprensible, inclusivo e intercultural dirigidas a la población de su jurisdicción.
i. Las IPRESS gestionan con su RIS una plataforma de transmisión síncrona de libre acceso, que permite la reproducción posterior de la temática desarrollada, a través de la creación de un repositorio digital audiovisual.
j. El responsable de Telesalud o el que haga sus veces en la IPRESS, programa las actividades de TeleIEC a desarrollar durante el año, en concordancia con las líneas de acción establecidas en el Plan de Telesalud en la región o DIRIS, según corresponda. Así como determina la población objetivo a la que se dirige la actividad de TeleIEC, en coordinación con los actores sociales e instituciones de su jurisdicción.

6.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE TELESALUD

a. La ANS desarrolla los estándares de calidad de la atención (QoC) a través de la Telesalud, considerando los recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias, a fin de planear, controlar y mejorar los procesos de la atención de servicios que influyen en la confianza, seguridad, eficacia de la atención y satisfacción del paciente.
b. La ANS para desarrollar los estándares de calidad para la atención de los servicios de salud a través de Telesalud, consideran los siguientes pilares:
   - Seguridad y confidencialidad de datos: Es fundamental garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos sensibles de los usuarios de Telesalud que reciben atención con Telemedicina, implementando medidas de seguridad adecuadas para proteger esta información.

- Prácticas clínicas basadas en evidencia: Es un proceso para asegurar que los servicios de salud a través de Telesalud sean lo más efectivos y seguros.
- Regulación legal: La Telesalud requiere de una regulación normativa clara, específica y actualizada para abordar aspectos según las complejidades. La falta de un marco legal no definido en este tipo de servicios genera vacíos normativos y dificultades para su aplicación.
- Formación y capacitación: El personal de la salud que participa en la prestación de los servicios de salud a través de Telesalud, cuenta con la formación y capacitación necesaria para garantizar la calidad de la atención de salud a distancia.
- Evaluación de la calidad de la atención: Se utiliza periódicamente medidas de evaluación a la calidad de la atención en Telesalud con estándares internacionales de calidad, validados y con certificaciones actualizadas.

6.3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE TELESALUD

a. La ANS determina los requisitos mínimos para brindar los servicios de salud a través de Telesalud, considerando las dimensiones tecnológicas, científicas, humanas y del entorno de la atención, e implementa según los estándares de calidad en Telesalud.
b. La ANS desarrolla los criterios técnicos para implementar la telementoría en las IPRESS a nivel nacional.
c. La ANS en coordinación con los órganos competentes, desarrollan los criterios técnicos para implementar acciones, considerando normas ISO, normas técnicas peruanas y mejores prácticas; ello sumado al marco normativo vigente en dicha materia.
d. La ANS a través de sus órganos competentes, desarrollan los criterios para implementar auditorías para fomentar la garantía de calidad de atención de los servicios de salud a través de Telesalud.
e. La ARS y ASLM o las que hagan sus veces e IPRESS, implementan actividades para realizar auditorías de la calidad de la atención en los servicios de salud a través de Telesalud, de acuerdo a las disposiciones emanadas del ente rector.
f. La ARS y ASLM o las que hagan sus veces e IPRESS, realizan auditorias Informáticas del proceso en la atención de los servicios de salud a través de Telesalud.

6.3.1. Recursos humanos

a. El profesional de la salud que desempeñe actividades relacionadas con los servicios de salud a través de Telesalud, se rige por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, que indica que, cuenta con título profesional en los casos que la Ley así lo establece y cumple con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento, habilitación y demás que dispone la Ley. En cuanto al personal técnico y auxiliar en salud que desarrolla actividades en los servicios de salud a través de Telesalud, estos cuentan con Título de Técnico y realizan la teleorientación.
b. En el marco de la teleinterconsulta, en el caso del profesional de la salud que se encuentra fuera del territorio nacional que brinde servicios de salud a través de Telesalud, debe cumplir con los requisitos establecidos por el Colegio Profesional al cual pertenece.
c. Los profesionales de la salud que brindan servicios de salud a través de Telesalud, anteponen los derechos fundamentales del paciente, humanizando la tecnología y

procurando que el acto médico o acto de salud cumpla con las condiciones éticas y deontológicas que correspondan.

6.3.2. Infraestructura

1. Física

a. Las IPRESS que brindan servicios de salud a través de Telesalud cuentan con el o los espacios físicos según corresponda, y se implementa de acuerdo al eje a desarrollar.
b. En caso de teleemergencia se utiliza la estación móvil de telemedicina preferentemente.

2. Tecnológica

a. Las IPRESS cuentan con infraestructura tecnológica (hardware, software) dispositivos médicos, equipos biomédicos digitales, equipos móviles y redes de comunicaciones, de acuerdo a su demanda.
b. Los dispositivos médicos de captura, de audio, imagen, video y data que tenga contacto con el paciente, cuentan con registro sanitario, cumple con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la transmisión confidencial e integral, además de una atención segura, utilizando la unidad de alimentación ininterrumpida o fuente de alimentación ininterrumpida.

6.3.3. Equipamiento

Las instituciones que implementan los servicios de salud a través de Telesalud cuentan, con el equipamiento necesario para la implementación de los servicios. Este equipamiento cuenta con la garantía, el soporte técnico del proveedor, el plan de mantenimiento preventivo y correctivo que, incluye la capacitación del uso del equipo para el personal de soporte y el usuario final.

1. Equipamiento Informático

a. Equipamiento de cómputo (computadora de escritorio o portátil), incorporado y/o equipado con periféricos de entrada y salida (cámara robótica o web, micrófono, parlantes y/o audífonos).
b. Monitor grado médico que muestra el máximo detalle y mejor calidad de las imágenes para elaborar el informe en el caso de teleapoyo al diagnóstico.
c. Impresora y escáner.
d. Sistema de videoconferencia (software o hardware).
e. Sistema de información interoperable.
f. Unidad de alimentación ininterrumpida.
g. Equipos de red.
h. Servidores, entre otros.

2. Equipamiento Biomédico

a. A fin de asegurar la atención en los servicios de salud a través de Telesalud de los usuarios de Telesalud y reforzar las atenciones, la IPRESS que implementa los servicios de Telemedicina cuenta con dispositivos médicos (equipos biomédicos digitales/electrónicos u otros), con registro sanitario otorgado por la DIGEMID, dichos equipos están registrados en el SIGA patrimonio, en IPRESS públicas, y el registro de gestión de patrimonio de equipamiento en IPRESS privadas.

b. Los dispositivos médicos (equipos biomédicos digitales/electrónicos u otros) para Telemedicina, cuentan con estándares para el intercambio electrónico de datos clínicos, con el SIHCE del MINSA y garantizan la seguridad de la información, así como, la protección de datos personales de los pacientes de Telesalud.

3. Mobiliario

Las IPRESS que brindan los servicios de salud a través de Telesalud, cuentan con mobiliario mínimo y materiales dentro de los ambientes que garantizan la privacidad durante la ejecución del servicio o actividad para el desarrollo de Telesalud, deben contener:

- Escritorio ergonómico.
- Sillas de escritorio ergonómicas.
- Estantes.
- Archivero con llave.
- Otros de acuerdo con la necesidad.

6.3.4. Conectividad y servicios

a. Las IPRESS que, brindan el servicio de salud a través de Telesalud gestionan el acceso al fluido eléctrico y el servicios de internet de forma continua y permanente con un sistema alternativo de energía para satisfacer la demanda principal en el servicio de Telemedicina, así como la seguridad informática, mediante la cual garantizan la conectividad de los diferentes equipos electrónicos (número de puntos de red para los equipos informáticos y biomédicos), brindando un adecuado nivel de seguridad informática a la información transmitida.
b. Las IPRESS que implementan los servicios de salud a través de Telesalud adquieren equipos biomédicos y dispositivos médicos que cuenten con Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID y credenciales para brindar los servicios de Telesalud, los cuales cuentan con protocolos de seguridad y trazabilidad de la información.

6.3.5. Sistemas de información

a. La ANS en coordinación con los órganos competentes, realizan las siguientes acciones para la gestión de la información de la Telesalud:
   - Uso de Sistema de videoconferencia (software o hardware).
   - Uso de SIHCE del MINSA u otro Sistema de Información que cuente con un componente de telemedicina o funcionalidades para la atención por telemedicina
   - Automatización de procesos (reportes), recopilación y manejo de la información.
   - Implementación de la gestión de datos personales en salud, conforme a la normatividad vigente.
   - Fortalecimiento del SIHCE del MINSA, en su componente de telemedicina para su uso en la gestión de la información relacionada a las prestaciones de telemedicina; lo cual incluye información sobre equipos biomédicos y dispositivos electrónicos.
   - Brinda las asistencias técnicas para el uso del componente de telemedicina del SIHCE del MINSA, a las DIRESA, GERESA y DIRIS; y, estas a su vez a la IPRESS.

b. Las IPRESS del sector público que cuentan con un sistema de información de Telemedicina realizan las gestiones con OGTI del MINSA para que su sistema interopere con el SIHCE del MINSA, de modo que la información de salud de las personas, esté a disposición del personal de la salud que brinda los servicios de salud a través de Telesalud.

c. Los siguientes dispositivos médicos (equipos biomédicos digitales/electrónicos u otros) son integrados al SIHCE del MINSA para las atenciones por telemedicina
   - Cámara de hendidura.
   - Cámara intraoral digital con monitor.
   - Dermatoscopio digital.
   - Ecógrafo digital.
   - Electrocardiógrafo digital.
   - Equipo de gases arteriales digital.
   - Estetoscopio digital.
   - Fonendoscopio digital.
   - Monitor de funciones vitales.
   - Monitor grado médico.
   - Otoscopio digital.
   - Oxímetro digital.
   - Retinógrafo digital.
   - Tensiómetro digital.
   - Videocolposcopio.

   Debiendo ser actualizado según el avance tecnológico existente.

6.3.5.1 Seguridad de la Información y tratamiento de datos

i. Seguridad de la información en los procesos de Telesalud

a. Las IPRESS que implementan y desarrollan los servicios de salud a través de Telesalud adoptan, disponen e implementan mecanismos que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información durante la transmisión y almacenamiento de los datos que custodian y transmiten; así como la implementación de planes de contingencia para evitar los riesgos de pérdida de datos y la recuperación de estos. Estas medidas de seguridad de la información, consideran medidas técnicas, organizativas y legales, en el marco legal de la protección de datos personales y de seguridad de la información, así como los demás aspectos relacionados a la seguridad (equipos, personal, etc.), y estas están alineadas a la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnologías de la Información, Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición".
b. El personal de la salud, el personal de soporte tecnológico y todo aquel involucrado en el tratamiento de datos personales en el marco de la prestación de los servicios de salud a través de Telesalud, está obligado a salvaguardar la información relacionada con el servicio de Telesalud; asimismo, considerar las medidas de seguridad tanto de protección de datos personales, gestión y de tecnología de la información.

ii. Protección de datos personales

a. La IPRESS debe obtener el consentimiento libre, previo, expreso e inequívoco del paciente o usuario de Telesalud para el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y en su Reglamento.
b. El paciente o su representante legal otorga a la IPRESS consultante su consentimiento para el tratamiento de datos personales en la realización de una tele interconsulta, para que la información referida a su identificación y salud sea enviada y tratada en la(s) IPRESS(s) consultora(s) estrictamente para los servicios de Telemedicina, pudiendo revocar dicho consentimiento en cualquier momento, con las

excepciones estipuladas en la legislación vigente aplicable. Si el paciente no supiese firmar, imprimirá su huella digital en señal de conformidad.

c. El referido consentimiento se realiza por escrito, con firma manuscrita o huella dactilar, cuando corresponda; por medio electrónico con firma electrónica o digital; o cualquier otro mecanismo electrónico autorizado por el ordenamiento jurídico que pueda reflejar la manifestación de voluntad expresa.
d. En el diseño y configuración de los servicios digitales en la Telesalud, se adoptan las medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental para asegurar la privacidad desde el diseño.
e. Las formas de tratamiento automatizado de datos personales, incluyendo el uso de IA que permita evaluar aspectos de la salud para elaborar perfiles de una persona y toma de decisiones automatizadas, se realizan previa autorización del titular del dato personal, a quien también se le comunica de manera previa la información relativa a las consecuencias del tratamiento automatizado. No está permitido el tratamiento de datos personales que produzca efectos jurídicos sobre su titular, tales como la discriminación contra él o aquellos que afecten sus derechos fundamentales, entre otros, de acuerdo a la normatividad vigente.
f. Las IPRESS que, para la prestación de servicios de salud a través de Telesalud realicen tratamiento de datos personales por medios tecnológicos tercerizados con o sin intervención humana, mantienen el control, las decisiones y la responsabilidad sobre el proceso mediante el cual se realiza el tratamiento de los datos personales.
g. Para la recolección y tratamiento de datos personales que se realicen en los servicios de salud a través de Telesalud, previamente se debe solicitar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del usuario de Telesalud.
h. Para atender los servicios de Telemedicina, el teleconsultante solicita el llenado y firma del consentimiento para el tratamiento de los datos personales del usuario de Telesalud, incluyendo la autorización de la transferencia de estos datos personales en caso se requiera.
i. La excepción a solicitar el consentimiento o autorización del tratamiento de datos personales estipulados en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, se da en casos de emergencia según lo señalado en el numeral 6 del artículo 14 de la referida ley.

6.3.6. Financiamiento de los servicios de salud, a través de Telesalud

a. Las IAFAS de acuerdo con sus Planes de Aseguramiento en Salud, financia a sus afiliados atenciones de los servicios de salud a través de Telesalud.
b. Las IPRESS que mantengan acuerdos de intercambio prestacional, convenios o contratos con otras IPRESS, IAFAS o UGIPRESS, cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente.

6.4. DE LA RED NACIONAL DE TELESALUD

a. Conformada por las IPRESS que cuentan con el servicio de salud a través de Telesalud en su cartera de servicios y que registran sus atenciones y/o actividades en Telesalud.
b. El MINSA fortalece los conocimientos del personal de la salud de las IPRESS que conforman la RNT, a través de la Telecapacitación.
c. La ANS utiliza el instrumento estandarizado para evaluar el grado de madurez y niveles de calidad de los servicios de salud a través de Telesalud.

d. La ANS, la ARS y ASLM realizan alianzas estratégicas para la implementación de los servicios de salud a través de Telesalud e incorporan IPRESS a la RNT para ampliar la oferta con los servicios de Telemedicina.
e. Las IPRESS e instituciones que integran la RNT, cuenta con un sistema de información interoperable y recursos tecnológicos para el tratamiento y administración de datos e información de los servicios de salud a través de Telesalud, el recurso humano (capacitado en el manejo de las TIC y en Telesalud), y la infraestructura, como se detallada en los numerales del 6.3.1 al 6.3.3 que desarrolla la presente normativa.
f. Las IPRESS e instituciones que integran la RNT, articula con todos sus integrantes para que desarrollen los ejes de la Telesalud: Prestación de los servicios de salud, Gestión de los Servicios de Salud, Información, Educación y Comunicación a la población sobre los servicios de salud, Fortalecimiento de capacidades del personal de la salud y otros de carácter técnico relacionados al uso de las TIC en la salud.
g. La ANS,ARS, ASLM impulsan y promueven la suscripción de convenios que favorezcan la integración para la prestación de los servicios de salud en las IPRESS que conformar la RNT que, aseguren la continuidad de la atención en el cumplimiento del principio de complementariedad en el marco de la RIS; garantizando el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones de salud centradas en el ciudadano entre las IAFAS, las IPRESS y las UGIPRESS públicas, generando una mayor cobertura y utilizando en forma eficiente la oferta pública disponible.

6.5. DEL CONTROL CON SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE TELESALUD

a. La ARS y ASLM o las que hagan sus veces, a través de la UFT o el equipo técnico, realizan la evaluación de los servicios de salud a través de Telesalud de su jurisdicción, lo consolidan y reportan a la ANS.
b. La ARS y ASLM o las que hagan sus veces realizan la evaluación de los indicadores de estructura, procesos, resultados e impacto definidos en el Plan de Telesalud en la región o DIRIS, según corresponda, de acuerdo con su ámbito de aplicación.
c. En las IPRESS el responsable de Telesalud realiza el monitoreo y seguimiento de las actividades de Telesalud.
d. Las IPRESS cumplen con los compromisos asumidos en la supervisión y monitoreo, e implementan mejoras de calidad según la evaluación de la implementación de los servicios de salud a través de Telesalud.
e. La ANS a través de la DIGTEL supervisa y monitorea la implementación de los servicios de salud a través de Telesalud.
f. La ANS a través de la DIGTEL determina indicadores, considerados como herramientas fundamentales para la gestión, la evaluación y la mejora continua de los servicios de salud a través de Telesalud. (Anexo)

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. Nivel Nacional

El MINSA, a través de la DIGTEL, es responsable de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud, así como de brindar asistencia técnica hasta el nivel regional, en coordinación con los órganos técnicos del Ministerio de Salud, según corresponda.

7.2. Nivel Regional

La ARS y ASLM son los encargados de la difusión, implementación, supervisión y monitoreo de la presente NTS en el ámbito de su competencia, así como de brindar asistencia técnica sobre el contenido.

7.3. Nivel Local

Las IPRESS son responsables de la aplicación de la presente Norma Técnica de Salud.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: ADECUACIÓN DE LA NORMA

Las IPRESS que brinden servicios de salud a través de Telesalud tienen un plazo de ciento cincuenta (150) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Norma Técnica de Salud para adecuarse a la misma.

SEGUNDO: FINANCIAMIENTO

La implementación de lo dispuesto en la presente norma es financiada con cargo al Presupuesto Institucional de los pliegos correspondientes, en el marco de la normativa vigente.

La ANS/DIRESA/GERESA/DIRIS e IPRESS, de acuerdo con su necesidad elaboran IOARR o proyectos de inversión y gestionan el financiamiento correspondiente para implementar los servicios de salud a través de Telesalud.

TERCERA: USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA

Los Establecimientos de Salud que brindan servicios de salud a través de Telesalud, deben asegurar la autenticidad, integridad y validez legal de los documentos generados como: recetas electrónicas, órdenes médicas, informes y formatos de Telemedicina. Para ello utilizan la firma digital, conforme a lo establecido en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su reglamento y otras normas vigentes.

IX. ANEXO

- Indicadores para la gestión, la evaluación y la mejora continua de los servicios de salud a través de Telesalud.

ANEXO
Indicadores para la gestión, la evaluación y la mejora continua de los servicios de salud a través de Telesalud.

I. TELEMEDICINA

A. INDICADORES DE ESTRUCTURA

a. Disponibilidad

a.1 Número de médicos programados en Telesalud/ población.
a.2 Número de personal de la salud según perfil profesionales programados en Telesalud/población.
a.3 Número de IPRESS que brindan los servicios de Telesalud/Número total de IPRESS.
a.4 Número de tele consultorios según UPSS implementados con el servicio de Telesalud/Número total de consultorios.
a.5 Turnos de programación para los servicios de Telemedicina.

b. Accesibilidad

b.1 Número de establecimiento de salud de primer nivel de atención con más de 4 horas de distancia a la capital de la provincia que brindan servicios de Telemedicina /población.
b.2 Pacientes asegurados que se atienden con Telesalud en establecimiento de salud de primer nivel de atención a más de 4 horas de caminos a la capital de la provincia
b.3 Número de pacientes atendidos por Telesalud que reciben su tratamiento farmacológico completo.
b.4 Número de pacientes atendidos por Telesalud.
b.5 Número de pacientes que esperan cita presencial atendidos por Telesalud.

B. INDICADORES DE PROCESO

a. Productividad

a.1 Atenciones por Telesalud/ horas programadas de médico en la IPRESS
a.2 Número de IPRESS con servicios de Telemedicina activo en RENIPRESS/Número de IPRESS a nivel nacional x 100.

b. Rendimiento

b.1 Atenciones por Telesalud/horas médico efectiva.

c. Intensidad de uso

c.1 N° de atenciones por Telesalud/N° de atendidos por Telesalud.
c.2 N° de atenciones por tipo de Telemedicina/N° de atendidos por tipo de Telemedicina.

d. Extensión de uso

d.1 N° de atendidos por tipo de Telemedicina en un periodo/Población asegurada en el mismo periodo x100.

e. Grado de uso

e.1 Atenciones por Telemedicina haciendo uso de los equipos biomédicos entregados a través de la IOARR de Telesalud /equipos biomédicos disponibles x 100.

f. Calidad

f.1. Tiempo promedio de respuesta de las solicitudes de los servicios de Telemedicina.

f.2. Número de tele monitoreos programados y realizados.
f.3. Número de recetas con tratamiento farmacológico no atendidas (parcial o sin atención)
Número de encuestas al usuario externo sobre los servicios de Telemedicina recibidos.
f.4. Número de encuestas al usuario interno sobre la percepción del uso de los servicios de Telemedicina.

C. INDICADORES DE RESULTADO

a. Cobertura

a.1 Número de atendidos por tipo de Telemedicina/población x 100
a.2 Número de tele interconsultas atendidas por profesional de la salud especializado.
a.3 Tasa de uso de los servicios de Telemedicina.

a.3.1 Primer Nivel

i. Teleconsulta:
Número de atenciones por tele consulta, identificadas mediante un código único, brindado por el establecimiento de salud/Población adscrita al establecimiento de salud x 100.

ii. Telemonitoreo:
Número de atenciones por tele monitoreo (considerando para la evaluación los códigos de trastornos hipertensivos, trastornos en salud mental, diabetes mellitus y anemia) / Población adscrita al establecimiento de salud x 100.

iii. Teleinterconsulta
Número de atenciones por Teleinterconsulta utilizando equipos biomédicos / Número total de atenciones por Telemedicina x 100.

a.3.2 Segundo y tercer nivel

Número de atenciones por tele interconsulta identificadas mediante código único, brindado por el establecimiento de salud consultor/ Número de atenciones realizadas en el establecimiento de salud por cualquier motivo de consulta x 100.

b. Eficacia

b.1 Número de quejas por atención con Telesalud.

c. Efectividad

c.1 Tiempo de atención a través del Componente de Telemedicina del SIHCE del MINSA

d. Eficiencia

d.1. Número de referencias evitadas por atención con Telesalud.
d.2. Número de atenciones por Telemedicina realizadas por profesional de salud.
d.3. Porcentaje de tele interconsultas programadas que son observadas.
d.4. Comparación de los costos de Telemedicina frente a consultas presenciales.

D. INDICADORES DE IMPACTO

d.1. Número de proyectos de inversión elaborados para asegurar la continuidad y expansión del servicio de Telesalud a largo plazo.
d.2. Número de proyectos de IOARR de Telesalud aprobados/ Número total de proyectos IOARR aprobados.

II. TELEGESTIÓN

A. INDICADORES DE ESTRUCTURA

a. Disponibilidad

a.1 Número de tele gestiones ejecutadas en Telesalud/ Número de tele gestiones programadas en Telesalud.

III. TELECAPACITACIÓN

A. INDICADORES DE ESTRUCTURA

a. Disponibilidad

a.1 Número de Telecapacitaciones ejecutadas / Número de Telecapacitaciones programados.

a.2 Número de personal de la salud beneficiado por Telecapacitaciones/Número total de personal de la salud capacitado.

b. Accesibilidad

b.1 Número de Telecapacitaciones realizadas al personal de la salud de forma adecuada /Numero de capacitaciones.

c. Indicador de proceso

c.1. N° de recursos humanos en el sector salud a nivel nacional certificados en los niveles básico, nivel intermedio y/o avanzado según corresponda en el Programa de Formación Laboral.

c.2. Gestión e Implementación de la Telesalud y/o cursos en alianzas estratégicas sobre Telesalud desarrollados por la Dirección de Telemedicina y la Escuela Nacional de Salud Pública/ N° de recursos humanos en el sector salud a nivel nacional.

IV. TELEIEC

A. INDICADORES DE ESTRUCTURA

a. Disponibilidad

a.1 Número de TeleIEC ejecutadas / Número de teleIEC programadas.

B. INDICADORES DE PROCESO

b. Productividad

b.1 Número de beneficiados por TeleIEC por IPRESS.

X. BIBLIOGRAFÍA

10.1. Programa Nacional de Telesalud. En el contexto de Redes Integradas de Servicios de Salud. Chile.
10.2. OMS. Proyecto de estrategia mundial sobre salud digital 2020–2025. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/documents/200067-lb-full-draft-digital-health-strategy-with-annex-cf-6jan20-cf-rev-10-1-clean-sp.pdf?sfvrsn=4b848c08_2.
10.3. World Health Organization 2021. 2021.Global strategy on digital health 2020-2025
10.4. OMS. OPS. Plan de Acción para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la Salud 2019-2023. 57° Consejo Directivo 71.a sesión del comité regional de la OMS para las américas.
10.5. Corfo Innova Chile. 2020.Fundamentos para los Lineamientos para el desarrollo de la Telemedicina y Telesalud en Chile Segunda Edición.
10.6. Banco Interamericano de Desarrollo. 2020. Gobernanza de la salud digital El arte de la transformación de los sistemas de salud.
10.7. Carnicero; Serra, P. 2020.Gobernanza de la salud digital El arte de la transformación de los sistemas de salud. Banco Interamericano de Desarrollo.
10.8. Banco Interamericano de Desarrollo.2021. Estudio sobre Telemedicina Internacional en America Latina.
10.9. Gong, J., & Zhao, G. (2020). Challenges and opportunities of 5G-enabled remote surgery: A review. Journal of Medical Systems, 44(9), 1-10. (Destaca la importancia de las redes de baja latencia como 5G para la telecirugía y los desafíos asociados).
10.10. Reiner, B. I., & Siegel, E. L. (2020). The digital operating room: A review of current technologies and future applications. Journal of Digital Imaging, 33(1), 1-10. (Aunque abarca el quirófano digital en general, la telecirugía es una aplicación clave dentro de este ecosistema digital).
10.11. Organización Panamericana de la Salud. 8 principios rectores de la transformación digital del sector de la salud: Un llamado a la acción panamericana. Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53730/OPSEIHIS210004_spa.pdf
10.12. OMS.OPS. 2021.Lista de dispositivos médicos prioritarios para el primer nivel de atención en los países de la Región de las Américas.
10.13. Estrategia de Salud Pública. 2022. Mejorando La Salud y el Bienestar de la Población.
10.14. World Health Organization. 2022. Who-ITU Global standard for accessibility of telehealth services.
10.15. Banco Interamericano de Desarrollo. 2022.La Gran Oportunidad de la Salud Digital en América Latina y el Caribe.
10.16. Asociación Española de Normalización (UNE). 2023.Estandares para la salud digital.
10.17. OPS. Banco Interamericano. 2023.Inteligencia Artificial en Salud Pública.
10.18. C. Vasquez.2024. Libro blanco de fortalecimiento del primer nivel de cuidado de la salud 2024/2027 En el marco de las Redes Integradas de Salud.
10.19. World Health Organization. 2024. Telehealth quality of care tool.
10.20. OPS.2024. Todo en uno Paquete de Telesalud.